



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : شيماء ممدوح محمود عبدالحافظ

العنوان : طهرمس

الحي / المدينة : بولاق الدكرور

المحافظة : الجيزة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 19-09-2026

رقم التليفون : 01142130525

رقم البطاقة : 29301210106684

العمر (تاريخ الميلاد) : 21-01-1993 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /..... /د. /..... /د. /..... /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: شيماء ممدوح محمود عبدالحافظ National ID: 29301210106684	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

شيماء
ممدوح محمود عبد الحافظ
أش. محمول مرسى - طريق كفر طهر مرس - بحري
بولاية الدكرور - الجيزة

١٩٩٣/٠١/٢١ ٢٩٣٠١٢١٠١٠٦٦٨٤
JD3996849

١٧٨٤
كارسيل

٢٠٢١/١٢ ٢٩٣٠١٢١٠١٠٦٦٨٤

حاصلة على ليسانس أدب
أنثى
متزوجة
مسلمة
حسين عزت حسين رياض موسى
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/١٢/٠١

١

MDT FORM

Name: / Mmdouh / Abd Elhafez	MRN: 3582
Age: 33 Y	ID:
Menopausal Sta	Phone: 01142130525
NRS SCORE:	Marital Status:
BMI:	Family History:
CO Morbidity:	Reason Of MDT:

Clinical Data:

BX:	UDC GII
ER: 6/8	PR: 6/8
HER2: 3	KI67:

Sonomammography:

Mets Workup:

History:

post NACT RT WLE + SLNB & completion axillary clearance >> residual viable IDC GII, free surgical margins, LNS 3/21, ypT3ypN1a

Recommendations:

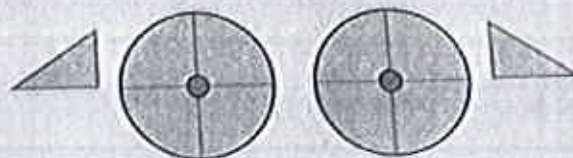
MDT Outcome & Plan

In view of having non-PCR (ypT3 N1) post-NACT (TCHP)...For:

1. Adjuvant Kadcyla x 12 cycles
2. PORT to Rt breast, CW & PCLN
3. Adjuvant ET (Zoladex/Femara)

R

L



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
4/3/2016					

Patient Name : الأستاذ / شيماء مدحوح محمود	Request No. : 13009230
Patient No. : 29301210106684	Request Date : 31/05/2025
Path No. : SR-769/25	Verification Date : 16/06/2025
Sex : Female	Financial Category : أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 32 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report**Clinical Data**

Right breast mass

Nature of specimen

Block & slide revision

Gross examination

One block labelled by (2953/25) & 3 slides were received

HC technique: Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench

Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2) PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination

* Histological type: Invasive duct carcinoma

* Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): (3+2+2) Grade III

* DCIS: No

* Angioinvasion: Positive

* Perineural invasion: No

* IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :

* ER: Strong nuclear reaction in 30 % tumor cells (Allred score 6/8)

* PR: Strong nuclear reaction in 30 % tumor cells (Allred score 6/8)

* HER2: Strong complete membrane reaction in >10 % of tumor cells (score 3+)

Diagnosis

Right breast mass, block & slide revision:

Invasive duct carcinoma, Grade III

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 25/06/2025 11:58:49

Page 1 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
 Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name	: الاستاذة / نيلما محمد محمود	Request No.	: 13009230
Patient No.	: 29301210106684	Request Date	: 31/05/2025
Path No.	: SR-769/25	Verification Date	: 16/06/2025
Sex	: Female	Financial Category	: أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 32 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

IFT:

* ER: Positive (score 6/8).

* PR: Positive (score 6/8).

* HER2: Positive(score 3+).

Signature

Dr.Walaa Ibrahim Ghoneim

Dr.Heba Hassan Adly

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 25/06/2025 11:58:49

Page 2 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذة / شيماء ممدوح محمود	Request No. : 13003950
Patient No. : 29301210106684	Request Date : 14/12/2025
Path No. : 3860/25	Verification Date : 23/12/2025
Sex : Female	Financial Category : جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age : 32 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer, Post-NACT.

Nature of the specimen: Right wide local excision, Sentinel lymph nodes biopsy & Completion axillary lymph nodes dissection.

Gross Examination:

- Right breast wide local excision specimen measured 11x10x4 cm, with no skin covering.
- Serialling showed a wire guided tumor bed site measured 6x5x3 cm, located 0.5 cm from the least lateral margin.
- SLNs: Multiple fibrofatty tissue pieces collectively measured 4x4 cm, entangling 6 lymph nodes, the largest was 1.5x1x0.5 cm.
- Completion axillary dissection: Fibrofatty tissue piece measured 7x3x2 cm, entangling 15 lymph nodes, the largest measured 2x1x0.5 cm.
- Total lymph nodes number is 21.
- 22 Blocks:
- 1- Medial margin., 2- Lateral margin., 3- Superior margin., 4- Inferior margin., 5- Superficial., 6- Deep margin., 7- Sentinel lymph nodes., 8:13- TBS., 14:18- Surrounding breast., 19:22- ALNs.
- Gross was done by; Dr. Heba El-Shafeey.

* Frozen (Intra-operative) Results:

- Free surgical margins.
- SLNs: Positive viable metastatic deposits in 3 out of 6 sentinel lymph nodes (3/6).

Microscopic examination:

- Histological type: Residual viable invasive duct carcinoma (Actual tumour size 6x5 cm) (Cellularity 35%).
- Grade 2 (differentiation 2, nuclear pleomorphism 2, mitosis 2).
- 10% Intermediate grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform pattern with comedo type necrosis).

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 28/12/2025 11:09:57

Page 1 of 3

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذ / شيماء ممدوح محمود	Request No. : 13003950
Patient No. : 29301210106684	Request Date : 14/12/2025
Path No. : 3860/25	Verification Date : 23/12/2025
Sex : Female	Financial Category : جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age : 32 Y	Department : Out Patient
Referreing Doc :	Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

- Microcalcification: Present.
- Perineural invasion: Absent.
- Angioinvasion: Present.
- Surgical margins: Free.
- SLNs: Positive viable metastatic deposits in three out of six sentinel lymph nodes (3/6) (The largest nodal mets measuring 3 mm with no extra-nodal extension).
- Completion axillary dissection: 15 lymph nodes free of metastatic deposits.
- Total nodal status: L.Ns (3/21) (The largest nodal mets measuring 3 mm with no extra-nodal extension).
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response to therapy.

Diagnosis:

Right breast cancer (Post-NACT), Right wide local excision, Sentinel lymph nodes biopsy & Completion axillary lymph nodes dissection:

- Residual viable invasive duct carcinoma, Grade 2 (Cellularity 35%) (Actual tumor size 6x5 cm).
- 10% Intermediate grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform pattern with comedo type necrosis).
- Surgical margins: Free.
- Total lymph nodes status: Positive viable metastatic deposits involving three out of twenty-one axillary lymph nodes, (3/21) (The largest nodal mets 3 mm in maximum dimension, with no extra-nodal extension).
- Pathologic partial response to therapy (PPR).
- Stage: ypT3, ypN1a.
- RCB: 3.662, RCB class-III.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 28/12/2025 11:09:57

Page 2 of 3

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذ / شيماء ممدوح محمود

Patient No. : 29301210106684

Path No. : 3860/25

Sex : Female

Age : 32 Y

Referring Doc :

Request No. : 13003950

Request Date : 14/12/2025

Verification Date : 23/12/2025

Financial Category : جوستاف روسي - نفقة الدولة

Department : Out Patient

Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Dr. Hiba El-Shafeey.

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 28/12/2025 11:09:57

Page 3 of 3

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

PATIENT NAME: SHAIMAA MAMDOUH MAHMOUD ABDELHAFEZ

GENDER: Female

DATE: 12-Feb-2026 01:44 PM

PATIENT ID: 10125263044

AGE: 33 y

ORDER: 3764394,3764395

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS

TECHNIQUE:

- Multislice helical CT acquisition with automatic IV low osmolar non-ionic contrast medium infusion 50 ml.

FINDINGS:

Reported case of breast cancer underwent CBS.

Compared to the previous study dated 25-5-2025, the current study shows:

1-CHEST

- Right CBS showing UOQ postoperative distortion with prominent right axillary tail lymph node measures about 5 mm.
- Stable left lower lobar and Middle lung lobe small pulmonary nodules, measuring about 0.3 cm in diameter.
- No sizable pulmonary masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- Still noted middle lung lobe fine parenchymal band.
- No CT evidence of pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers.
- No pericardial effusion detected.

2- ABDOMEN AND PELVIS

- The liver is mildly enlarged with the non apprecaton of the previously

PATIENT: SHAIMAA MAMDOUH MAHMOUD ABDELHAFEZ, 10125263044, Female, 33 y

Report version 2, 14-Feb-2026 04:29 PM

Page 1 of 2



www.Baheya.org



16602

مركز بحوث الأهرام
شارع غامبة بول شارع الهرم بحوار دري، الحيزة

مستشفى وحدة الشيخ زايد
الحي الأول، الشيخ زايد، أمام كلية الهندسة



[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

noted left hepatic lobe small focal lesion, (reported as flash filling hemangioma) . No other hepatic focal lesions, No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.

Potent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.

Uterine few myometrial calcified lesions, likely fibroids.

Normal appearance of the pancreas, spleen (and adjacent splenule),

Kidneys, adrenals, aorta, I.V C and the rest of pelvic organs.

Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.

No pathologically enlarged abdominal or pelvic lymph nodes.

Minimal pelvic ascites, likely physiological.

Near resolution of the Bilateral adnexal cysts.

The revised bone window revealed:

1. L1 vertebral body intra-osseous hemangioma.
2. No CT evidence of vertebral collapse or extra-osseous soft tissue component..

Opinion:

- Right interval CBS showing UOQ postoperative distortion with prominent right axillary tail lymph node For US correlation
- Rather stationary course of the rest of the study.

Reported By,

Dr. Ahmed Abdel-Monem, MSc

Dr. Mennatallah Mohamed, MD

14-Feb-2026 04:29 PM



Yohc

PATIENT NAME: SHAIMAA MAMDOUH MAHMOUD ABDELHAFEZ

GENDER: Female

DATE : 14-Feb-2026 01:11 PM

PATIENT ID: 10125263044

AGE: 33 y

ORDER: 3765805

99MTC-MDP BONE SCAN

Desired Information: -
skeletal survey.

Technique:

Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 hours after I,V administration of 20 mCi 99m Tc-MDP in the following manner:

Report:

No hot spot that account for osseous deposits could be detected all over the surveyed skeleton.

Degenerative changes are seen over dorso-lumbar vertebrae.

Both kidneys are normally visualized.

Conclusion:

No definite evidence of metastatic osseous deposits.

Reported By,

Prof. Huda Fathy, Nuclear Medicine Consultant

14-Feb-2026 01:47 PM

